Клинические рекомендации

Вирусные менингиты у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A87.0** — Энтеровирусный менингит (G02.0*) **A87.1** — Аденовирусный менингит (G02.0*) **A87.2** — Лимфоцитарный хориоменингит **A87.8** — Другой вирусный менингит **A87.9** — Вирусный менингит неуточненный **B00.3** — Герпетический менингит (G02.0*) **B01.0** — Ветряная оспа с менингитом (G02.0*) **B02.1** — Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0*) **B05.1** — Корь, осложненная менингитом (G02.0*) **B26.1** — Паротитный менингит (G02.0*) **G02.0** — Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **G03.9** — Менингит неуточненный
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/995_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **4**

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Инструментальные исследования 6

3.5 Дифференциальная диагностика 6

4. Лечение **6**

4.1 Этиотропное лечение 6
4.2 Патогенетическая терапия 7
4.3 Симптоматическая терапия 7
4.4 Медицинская реабилитация 7
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Профилактика 7
5.2 Диспансерное наблюдение 8
5.3 Показания к госпитализации 8
6. Источник и актуальность 8
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Вирусный менингит протекает с серозным воспалением оболочек мозга и гипертензионно-гидроцефальным синдромом. Чаще всего его вызывают энтеровирусы (до 58%), герпесвирусы, реже аденовирус, вирусы кори, паротита, гриппа.
- Диагноз основан на клинике (общемозговые, менингеальные, очаговые симптомы после инкубационного периода **2–30 дней**), обнаружении антител IgM или нарастании IgG и вирусной РНК/ДНК методом ПЦР в крови и цереброспинальной жидкости, эпидемиологическом анамнезе. Спинномозговая пункция — **в первые сутки** при отсутствии противопоказаний.
- Для оториноларинголога: при паротитном менингите часто развивается неврит VIII пары черепных нервов — системное головокружение, рвота, нистагм; при тяжёлом течении и подозрении на нейросенсорную тугоухость регистрируются акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП).
- При подозрении на вирусный менингит показана экстренная госпитализация в инфекционный стационар с ОРИТ. Лечение — этиотропное (противовирусные препараты, интерферон альфа-2b), патогенетическое и симптоматическое; антибиотики — только при бактериальных осложнениях.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Вирусный менингит (ВМ) — полиэтиологичное вирусное заболевание, характеризующееся серозным воспалением в оболочках головного мозга с преобладанием гипертензионно-гидроцефального синдрома.

2.2 Этиология и эпидемиология

ВМ развиваются при любых вирусных инфекциях с вовлечением нервной системы в результате нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Наиболее частые причины — энтеровирусы и герпесвирусы, реже аденовирус, вирусы кори, эпидемического паротита, гриппа. Вакцинация снижает вероятность неврологических осложнений.

Входными воротами инфекции при первичном ВМ является слизистая оболочка носоглотки, бронхов, желудочно-кишечного тракта; вторичные ВМ носят иммунокомплексный и аллергический характер.

У детей ВМ встречаются в 5–8 раз чаще, чем у взрослых, чаще у мальчиков. В этиологии преобладают энтеровирусы (до 58%), с пиком заболеваемости в июне — октябре.

2.3 Классификация

1. **по первичному очагу** — первичные (энтеровирусные, лимфоцитарный хориоменингит, клещевой энцефалит) и вторичные (грипп, герпес, ВИЧ и другие инфекции)
2. **по течению** — острое — санация ЦСЖ **в течение 4 недель**, затяжное — **4–12 недель**, хроническое — **более 3 месяцев**
3. **по этиологии** — энтеровирусный, лимфоцитарный хориоменингит, герпесвирусный, паротитный, гриппозный, аденовирусный, вызванный вирусами кори, краснухи, клещевого энцефалита, ВИЧ и др.

1. **по форме** — начальный (цитоз 15–50×10^6/л) и выраженный
2. **по тяжести** — среднетяжёлое (плеоцитоз до 150×10^6/л, белок до 0,7 г/л, без осложнений) и тяжёлое
3. **осложнения** — внутричерепная гипертензия, гидроцефальный синдром, диэнцефальный синдром

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина любого ВМ — сочетание общемозговой симптоматики, менингеального и общеинфекционного синдромов, а при поражении вещества мозга — очагового синдрома.

При энтеровирусном менингите у 25–90% пациентов отмечаются экзантема, энантема, миалгии, лихорадка двухволновая. У 15–20% детей менингеальных симптомов нет, но есть головная боль, рвота и светобоязнь.

1. **ЦСЖ** — прозрачная, давление 300–400 мм вод. ст., лимфоцитарный плеоцитоз 30–800 клеток в 1 мкл
2. **санация ЦСЖ** — **на 14–20 сутки**
3. **новорождённые и дети до 2–3 месяцев** — ВМ протекает по типу неонатального сепсиса

ВМ, вызванные Коксаки В, реже Коксаки А, ECHO, ЭВИ-71, протекают тяжелее, особенно **у детей до 5 лет**. Течение двухфазное.

1. **первая фаза** — синдром «рука — нога — рот», катаральные явления по типу ринофарингита
2. **вторая фаза** — **на 3–6 сутки** — серозный менингит, острые вялые параличи, ромбэнцефалит

Паротитный менингит развивается чаще **на 3–6 день**, реже **до 30 дня** после припухания слюнных желёз; у 4% — без клинических признаков их воспаления. Острый период — 5–7 дней, санация ликвора — к 18–20 дню.

Часто встречается неврит VIII пары черепных нервов: системное головокружение, рвота, нистагм; движения глаз и головы усиливают головокружение, дети стараются лежать неподвижно. Вестибулярные нарушения держатся несколько дней и постепенно проходят. Паротитный менингит может быть поствакцинальным осложнением.

1. **герпетический менингит** — относительно лёгкое течение; горизонтальный нистагм, гиперрефлексия, гиперестезия, светобоязнь; лимфоцитарный плеоцитоз до 200–800 клеток в 1 мкл
2. **ветряночный менингит** — на 5–7 сутки от появления сыпи; у трети — анизорефлексия и атаксия; выздоровление на 3–4 неделе
3. **при опоясывающем герпесе** — выраженный общеинфекционный синдром, ганглиониты и ганглионевриты, лёгкие менингеальные симптомы
4. **лимфоцитарный хориоменингит** — у детей раннего возраста возможны судороги, нарушение сознания, септический шок; плеоцитоз 100–1500 клеток; у 30–50% — изменения глазного дна
5. **клещевой энцефалит** — одно- или двухволновое течение, мелкоразмашистый нистагм, статическая атаксия; санация на 3–4 неделе, возможна хронизация (3%)
6. **коревой, аденовирусный, гриппозный** — без значимых клинических особенностей

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз ВМ устанавливается на основании

1. физикального обследования: общемозговые, и/или очаговые, и/или менингеальные симптомы после инкубационного периода **2–30 дней**;
2. лабораторных исследований: специфические антитела IgM и нарастающий титр IgG в крови и ЦСЖ к подозреваемым вирусам и/или вирусная РНК или ДНК методом ПЦР в крови и ЦСЖ;
3. эпидемиологического анамнеза: контакты с больными, пребывание в эндемичных регионах, контакты с грызунами, присасывание клеща, употребление сырого козьего молока, вакцинация.

3.2 Физикальное обследование

При осмотре обращают внимание

1. общеинфекционная симптоматика: интоксикация, лихорадка;
2. общемозговая симптоматика: головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, кожная гиперестезия;
3. менингеальные симптомы;
4. очаговая неврологическая симптоматика.

1. **инфекционист** — всем при подозрении на ВМ
2. **офтальмолог** — перед спинномозговой пункцией: застойные явления на глазном дне — противопоказание к пункции
3. **невролог** — всем с ВМ, оценка сознания по шкале комы Глазго, менингеальных и очаговых симптомов

3.3 Лабораторные исследования

Всем пациентам выполняются общий (клинический) анализ крови и спинномозговая пункция **в течение первых суток** при отсутствии противопоказаний.

Исследование ЦСЖ

1. микроскопия, цитоз;
2. глюкоза, белок, лактат;
3. натрий, хлориды.

Для ВМ характерен умеренный плеоцитоз (до 1000 клеток в 1 мкл) с преобладанием мононуклеаров и незначительное повышение белка.

При подозрении на отёк головного мозга и других противопоказаниях спинномозговая пункция не проводится до стабилизации состояния.

Повторная спинномозговая пункция проводится **на 7–10 сутки**.

ПЦР крови — всем пациентам

1. ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типов, варицелла зостер;
2. ДНК цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр, герпеса 6 и 7 типов;
3. по эпидемическим показаниям — ДНК боррелий и антиген вируса клещевого энцефалита.

В ЦСЖ методом ПЦР определяются ДНК герпесвирусов, РНК неполиомиелитных энтеровирусов, ДНК парвовируса B19, РНК вируса краснухи, ДНК боррелий. Отрицательный результат при первом обследовании заболевание не исключает.

Одновременно с ПЦР методом ИФА определяются антитела к вирусам, способным вызвать ВМ, — в остром периоде и в динамике.

На острую инфекцию указывают IgM и/или нарастание титра IgG в 2–4 раза и более в парных сыворотках; однократное выявление IgG острой инфекцией не считается.

Серологическое исследование ликвора проводится в остром периоде и в динамике; антитела в ЦСЖ появляются позже, чем в крови, почти всегда к 10 суткам.

При подозрении на васкулит исследуется система гемостаза: коагулограмма, D-димер.

Для дифференциальной диагностики с бактериальным менингитом и безопасности терапии выполняются биохимический анализ крови и общий анализ мочи.

При подозрении на бактериальные осложнения или сепсис исследуются С-реактивный белок и прокальцитонин.

3.4 Инструментальные исследования

При тяжёлом течении в остром периоде регистрируются акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП) — для выявления нарушения проведения на стволовом уровне и при подозрении на нейросенсорную тугоухость как осложнение тяжёлого ВМ. АСВП позволяют диагностировать менингоэнцефалит и синдром внутричерепной гипертензии.

1. **УЗИ головного мозга** — всем с нарушением сознания — отёк, смещение срединных структур
2. **УЗИ глазного яблока** — при подозрении на внутричерепную гипертензию — толщина зрительного нерва
3. **ЭЭГ** — при нарушении сознания и судорогах
4. **зрительные вызванные потенциалы** — при тяжёлом течении с признаками внутричерепной гипертензии
5. **КТ головного мозга с контрастированием** — при подозрении на паранеопластический синдром, объёмное образование
6. **МРТ головного мозга с контрастированием** — при очаговой симптоматике — менингоэнцефалит, осложнения

При внутричерепной гипертензии, судорогах и нарушении сознания показана консультация анестезиолога-реаниматолога для решения о переводе в ОРИТ.

3.5 Дифференциальная диагностика

ВМ дифференцируют с инфекционными и неинфекционными заболеваниями ЦНС, в том числе с онкопатологией; решающее значение имеет отсутствие воспалительных изменений в ЦСЖ у неинфекционных заболеваний, сезонность и указание на укусы клещей.

С бактериальным гнойным менингитом дифференцируют при смешанном или нейтрофильном плеоцитозе; дополнительно определяют нейроспецифические белки: для ВМ характерны нейронспецифическая енолаза **до 3,0 нг/мл**, глиальный фибриллярный кислый белок **до 1,0 нг/мл**, белок S100 **до 200 нг/л**.

---

4. Лечение

При подозрении на ВМ всем пациентам показана экстренная госпитализация в стационар с инфекционными койками и ОРИТ из-за возможного внезапного утяжеления состояния. Лечение включает этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию; хирургическое лечение не проводится.

4.1 Этиотропное лечение

Детям **старше 4 лет** назначается интерферон альфа-2b или иммуностимуляторы; противовирусные препараты системного действия показаны всем пациентам — как можно раньше.

1. **герпесвирусная этиология** — ацикловир по инструкции
2. **клещевой энцефалит** — #рибавирин 10 мг/кг/сут в 2–3 приёма **14 суток**, контроль ЭКГ
3. **дети старше 7 лет, в том числе энтеровирусный менингит** — #тилорон: 7–12 лет — 60 мг/сут, старше 12 лет — 125 мг/сут однократно 7 дней, затем через день 5 дней

При невозможности терапии #рибавирином назначают другие иммуностимуляторы: #меглюмина акридонацетат детям **старше 7 лет** — 10 мг/кг 1 раз в день перед едой в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 день. После курса при клещевом энцефалите — технологически обработанные антитела к гамма-интерферону.

Антибактериальные препараты системного действия назначаются только при вторичных бактериальных осложнениях (стартово — цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам); при отсутствии очагов бактериальной инфекции не показаны.

4.2 Патогенетическая терапия

1. **внутричерепная гипертензия и отёк мозга** — консультация анестезиолога-реаниматолога
2. **отёк головного мозга** — кортикостероиды системного действия, предпочтительно дексаметазон
3. **синдром внутричерепной гипертензии** — ангиопротекторы: #эсцина лизинат 0,15 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно капельно, курс от 10 дней
4. **нейропротекция с острого периода** — #инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота 0,6 мл/кг (максимум 10 мл) внутривенно 1 раз в день **до 10 дней**; левокарнитин
5. **крайне тяжёлое течение** — иммуноглобулин человека нормальный внутривенно

4.3 Симптоматическая терапия

При температуре **выше 38,5 °C** и/или плеоцитозе **более 300 клеток в 1 мкл** применяют ибупрофен (детям **старше 3 месяцев**) или другие анальгетики и антипиретики — парацетамол (детям **старше 1 месяца**).

При судорогах применяют противоэпилептические препараты; препарат выбора — вальпроевая кислота, показанием служит даже однократный приступ. Одновременно с меропенемом вальпроевая кислота не назначается: он снижает её концентрацию.

Для нейропротекции и купирования экстрапирамидных нарушений **с 5–7 дня** назначается пирацетам, а также #деанола ацеглумат, гопантеновая кислота, #полипептиды коры головного мозга скота; при тяжёлых формах **с 3–5 дня** — поливитамины (детям старше 1 года).

4.4 Медицинская реабилитация

В раннем восстановительном периоде показана консультация врача по лечебной физкультуре; при стихании острого процесса — лечебная физкультура в зависимости от тяжести.

Принципы реабилитации

1. начало в периоде ранней реконвалесценции;
2. последовательность и преемственность этапов;
3. комплексный характер с участием разных специалистов;
4. адекватность нагрузок адаптационным возможностям, постоянный контроль эффективности.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Рекомендуется вакцинация детей против вирусных инфекций, которые могут осложняться ВМ, по Национальному календарю профилактических прививок; плановые схемы имеют приоритет над экстренными.

1. учёт контактов с инфекционными больными;
2. личная гигиена и термическая обработка продуктов;
3. предупреждение контактов с переносчиками.

5.2 Диспансерное наблюдение

Все дети-реконвалесценты ВМ находятся под диспансерным наблюдением; кратность и сроки определяет лечащий врач. Снятие с учёта — при полном восстановлении работоспособности, удовлетворительном самочувствии, отсутствии клинических признаков и очаговой симптоматики, сероконверсии.

5.3 Показания к госпитализации

При подозрении на ВМ показана экстренная госпитализация вне зависимости от этиологии, формы и тяжести — в стационар с ОРИТ; при нарастающей внутричерепной гипертензии и отёке мозга транспортировка — бригадой анестезиологии-реанимации.

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния;
2. отсутствие интоксикации;
3. значительное снижение или исчезновение неврологического дефицита.

Лабораторные критерии выздоровления

1. вирусная РНК, ДНК или антиген методом ПЦР не обнаруживаются;
2. отсутствие IgM **не позднее 3 месяцев** от начала или их снижение после терапии;
3. отсутствие нарастания титра IgG через 3 и более месяцев, нормализация состава ЦСЖ.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Вирусные менингиты у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	995_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Ассоциация врачей инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.